

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – CAMPUS BALNEÁRIO CAMBORIÚ
ARQUITETURA E URBANISMO

YASKARA NOGUEIRA DE SOUZA

**HUMANIZAÇÃO NA AMBIÊNCIA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS: PELA
PROMOÇÃO DO BEM - ESTAR E PREVENÇÃO DOS TRANSTORNOS MENTAIS
LEVES**

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

2026

01. INTRODUÇÃO

Inseridos na dinâmica de fluidez da vida contemporânea, na qual a aceleração constante torna-se o objetivo central, observa-se que as patologias e os desconfortos psíquicos acompanham uma tendência de aumento progressivo que afeta a população. Conforme Kehl (2009, p. 172), os transtornos mentais (TM) resultam da relação estabelecida com o tempo e com a velocidade cotidiana, fatores que ampliam a propensão a sofrimentos psíquicos.

De acordo com a Classificação Internacional de Transtornos Mentais e de Comportamento (CID-10, 2007), os TM são caracterizados como doenças com manifestações psicológicas associadas a comprometimentos funcionais, oriundos de disfunções biológicas, sociais, psicológicas, genéticas, físicas ou químicas. Tais condições manifestam-se como alterações no modo de pensar ou no humor, vinculadas a uma angústia expressiva que gera prejuízos no desempenho global do indivíduo nos âmbitos pessoal, social e ocupacional.

Dessa maneira, visto que o dinamismo acelerado nos meios urbanos atua como um catalisador para o sofrimento psíquico, os ambientes construídos deixam de ser meros cenários inertes e passam a ser redefinidos como fatores determinantes de saúde social (VASCONSELOS, 2014). Uma vez que, o bem-estar físico e mental é moldado diretamente pelos espaços onde o indivíduo habita e interage (ULRICH, 1984).

Nota-se que o suporte espacial é indissociável da eficácia do cuidado integral, sob a perspectiva do bem-estar e das iniciativas de promoção a saúde. Acentua-se o debate sobre o desenvolvimento de novas estratégias para enfrentar a demanda por estilos de vida mais saudáveis. Assim, torna-se uma alternativa viável de cuidado, fomentado por discussões sobre novos modelos de saúde e a importância de equipamentos de apoio que integrem o suporte espacial ao tratamento psíquico.

Contudo, apesar da crescente adoção por Práticas Integrativas e Complementares no Brasil, inexistem diretrizes arquitetônicas específicas para suas ambiências (VILLELA, 2022). O fenômeno investigado é, portanto, a inadequação dos espaços construídos destinados às PICs frente às demandas para a humanização e promoção do bem-estar psíquico.

02.JUSTIFICATIVA

De acordo com dados da OMS - Organização Mundial de Saúde (2015) estima-se que, uma em cada dez pessoas no mundo, 10% da população global, sofre de algum distúrbio de saúde mental (UNA-SUS, 2015). A mesma, define o conceito de bem-estar, afirmando que a saúde é o estado de completo bem-estar, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade. No Brasil,

atualmente estima-se que cerca de 18 milhões de brasileiros convivem com transtornos mentais. Além, dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) apontam que aproximadamente 20% da população brasileira apresenta sintomas de ansiedade ou depressão. Por isso, o Brasil é considerado o país com a maior incidência de depressão da América Latina e o segundo maior de todas as Américas.

Dito isso, as Práticas Integrativas e Complementares, são abordagens terapêuticas que têm como objetivo prevenir agravos à saúde, a promoção e recuperação, enfatizando a construção de laços terapêuticos e a conexão entre ser humano, meio ambiente e sociedade (OMS, 2025), permitindo abordagens utilizadas em recursos terapêuticos capazes de tratar e prevenir diversas patologias. No Brasil, é possível encontrar as PIC sendo ministradas em hospitais, públicos e privados, Centros de Saúde do SUS, entre outros (VILELLA, 2021). Vilella (2021, p.4) também menciona que, não existem diretrizes específicas para ambiências de PIC, cuja demanda pode ser diferenciada dos estabelecimentos de saúde convencionais e apesar da crescente adoção das Práticas Integrativas e Complementares no Brasil, como mencionado, nota-se a ausência arquitetônica concebidas exclusivamente para este fim. Nesse enfoque, do ponto de vista da arquitetura dos ambientes e da interação humano-ambiental resultante de sua ocupação, adota-se aqui a definição de Malard (1993):

[...] Humanizar espaços significa torná-los adequados ao uso dos humanos; torná-los apropriados e apropriáveis. Apropriação envolve a interação recíproca usuário/espaço, na qual o usuário age no sentido de moldar os lugares segundo suas necessidades e desejos. Os lugares, em contrapartida, tornam-se receptivos. Essa influência mútua entre usuário/espaço é a razão pela qual as pessoas e os grupos encontram — ou não — sua identidade nos diversos lugares em que vivem.

A fim de conter um equilíbrio deste cenário, a visão implementada em um Projeto Arquitetônico torna-se indispensável para a reflexão em torno do espaço usual dedicado a manutenção da saúde de forma integral e consequentemente de suas atividades. É importante ressaltar que a arquitetura em si, uma combinação de planejamento e construção, não possui o papel de cura. Contudo, se um projeto tiver como enfoque o ser humano integralmente refletido em seu design, ao atender diretrizes que buscam qualificar o espaço juntamente com práticas complementares como suporte do tratamento, é capaz de proporcionar o equilíbrio do bem-estar e a redução dos sintomas de TM, já que Pallasmaa (2011, p.11) defende que, os tratamentos oferecidos no espaço devem atuar juntamente com a arquitetura, criando um elemento transformador.

[...] uma edificação além de cumprir suas funções de usos, deve intensificar a vida de seus usuários, estimulando seus sentidos.

Portanto através da obra a arquitetura é capaz de explorar a sensação de realidade e identidade pessoal, reforçando-a por meio da integração entre espaços vivenciados, pessoas e suas experiências de mundo.

Com isso, o presente trabalho tem o intuito de abordar os transtornos mentais relacionados apenas às doenças consideradas de grau leve, como: estresse, ansiedade e depressão, comuns na sociedade contemporânea.

A arquitetura é, fundamentalmente, uma forma de linguagem que pode equilibrar essa realidade. A edificação ainda que de forma não consciente para seu observador, está em constante comunicação com as pessoas que com ela entram em contato. Como exemplo implantado na Europa, centros de tratamentos oncológicos intitulados como Maggie's Centers realizam terapias em espaços solícitos, pensados em auxiliar e apoiar aqueles que passam o processo de cura em seus tratamentos, promovido pelo design, fluxo de pessoas e contato com a natureza.

03. OBJETIVOS

03.01 Objetivo Geral

Desenvolver um anteprojeto arquitetônico de um espaço exclusivo para Práticas Integrativas da Saúde, de modo a promover o bem-estar integral do usuário.

03.02 Objetivos específicos

- Desenvolver espaços que promovam as condições adequadas para aplicar as Práticas Integrativas ao equilíbrio psíquico;
- Propor áreas imersivas e de permanência no espaço por meio do design e da arquitetura;
- Integrar espaços para maior interação entre áreas internas e os espaços externos.

04. REVISÃO DE LITERATURA

4.1 Medicina Integrativa e Complementar em síntese

A Medicina Ocidental contemporânea fundamenta-se no modelo biomédico, que, embora tenha oferecido soluções tecnológicas importantes, passou a focar intensamente na doença e na superespecialização. Essa abordagem "mecanicista" baseada em apenas evidências clínicas, tende a separar corpo e mente, deixando em segundo plano a prevenção, o estilo de vida e o bem-estar emocional. Como consequência, a partir da segunda metade do século XX, surgiu uma revisão crítica desse modelo, impulsionada pelos cidadãos que passaram buscar e proclamar que suas necessidades e emoções fossem vistas de forma mais integrada e respeitosa.

Nesse cenário de insatisfação a expressão alternativa veio à tona pela população e conforme ganhou força, o termo foi enunciado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1962, no singular, como alternativa à medicina contemporânea no intuito de tornar distinta, tendo definindo-a como uma prática desprendida da medicina tradicional.

A palavra integrativa descrita pelo dicionário refere-se a “práticas que integram todas as ações visando o bem-estar físico, psíquico, mental, cultural e social do cidadão”, ou seja, diferentes modelos para oferecer um cuidado integral.

Foi principalmente a partir da década de 1990 que instituições acadêmicas e científicas passaram a incorporar essas abordagens de forma estruturada, consolidando a Medicina Integrativa como um campo que une terapias convencionais e complementares, com foco no cuidado integral do indivíduo. Nos anos 2000, o conceito amadureceu para a denominação de Medicina Integrativa e Complementar, surgindo da necessidade de um modelo que visualizasse a saúde não apenas como a ausência de patologia (OTANI; BARROS, 2011 apud CASPI, 2003), mas como um estado resultante da promoção da saúde e da prevenção de doenças, valorizando a relação terapêutica e a capacidade inata do corpo para a cura.

4.3 A Arquitetura na Medicina Integrativa e Complementar

A literatura aponta um consenso sobre a restauração da humanização na saúde, mas observa tensões metodológicas na concepção do suporte espacial. No eixo do cuidado integral, embora as PICs busquem a conexão entre ser humano e meio ambiente, existe uma resiliência de diretrizes específicas, o que frequentemente confina essas práticas a ambientes hospitalares convencionais e monótonos.

A arquitetura para a saúde deve dialogar com instrumentos normativos. No Brasil, o projeto de estabelecimentos de saúde é regido pela RDC 50/2002 da ANVISA, que estabelece padrões físicos mínimos.

Para as PICs, essa tensão indica que a ambiência deve unir a eficácia biológica (conforto) e à profundidade subjetiva (pertencimento). O desafio desta revisão torna-se equilibrar o rigor dessas normas técnicas com a flexibilidade necessárias para as PICs, buscando uma síntese que garanta segurança sanitária sem comprometer a atmosfera terapêutica necessária para o tratamento de transtornos mentais leves.

4.3.1 Instrumento de Cuidado Integral: Aspecto Gerais

Reconhecendo a importância de novas diretrizes no padrão arquitetônico em meio hospitalares, o Ministério da Saúde lançou o - Programa Nacional de

Humanização de Assistência Hospitalar (PNHAH) - nos anos 2000, onde o objetivo central não se trata de negar os aspectos científicos e racionais presentes no sistema de saúde, mas de resgatar os valores humanos que foram perdidos, atualizá-los e empregá-los novamente a população. De acordo com o PNHAH (2001), *“a evolução do conhecimento técnico-científico não tem sido acompanhada por um correspondente avanço na qualidade do contato humano presente em toda intervenção do atendimento à saúde”*.

Ao tornar um espaço agradável para o ser humano, é papel do Arquiteto e Urbanista proporcionar o maior aconchego e familiarização possível (VASCONSELOS, 2014). Segundo Figueiredo (2005), quando um espaço é bem projetado pode ser considerado como um espaço qualitativo para tratamentos se levar em consideração as influências dos seis principais elementos ambientais no aspecto fisiológico, sendo eles: a luz, a cor, o som, o aroma, a textura e a forma que aguçam a sensibilidade do tato, paladar, visão, olfato e a audição ocasionando a sensação do bem-estar de forma completa. Isso acontece por que o receptor dessas mensagens as transforma em *“[...] respostas complexas em formas de sentimentos, atitudes, valores, expectativas e desejos”* (Figueiredo, 2005). Contribuindo com sua perspectiva, o autor Ulrich (1984) aponta evidências científicas que mostram que projetos arquitetônicos desestimulantes geram efeitos negativos fisiológicos, sendo ansiedade, delírio e pressão alta:

A arquitetura é um amplificador de mensagens morais, não um criador de emoções, porém, com um uso bem aplicado do espaço, da luz e do programa, as atividades que ocorrem em sua parede podem assumir um significado arquitetônico que apenas um papel de apoio na trama [...]

Para o autor Pallasma (2011), o bem-estar físico e mental não decorre de estímulos visuais isolados, mas de uma experiência multissensorial que envolve o corpo em sua totalidade, uma vez que o ambiente construído deve funcionar como um refúgio para a memória e a imaginação. A atmosfera espacial possui um caráter intermediário, ela não está apenas no objeto, nem apenas no sujeito, mas na ação exercida pelo espaço sobre quem o percebe. Nas palavras de Jamieson (2002), ao descrever como seriam espaços de saúde humanizados, o autor compara o ambiente a vida marinha, onde diz que *“[...] eu vejo os hospitais como um recife de corais: cheios de vida, de energia e de atividade [...]”*.

É preciso ter em mente de que a pessoa que utiliza o espaço é a peça fundamental na definição de que este ambiente é projetado para ela, proporcionando autonomia e liberdade para suas ações, pois como já frisado anteriormente, sua falta ou a indução de monotonia causa distúrbios psicológicos. A percepção sobre os elementos (como cores, sons, aromas), podem e devem integrar múltiplos sentidos simultaneamente.

Por fim, como define Kaplan (1977) a integração entre o ambiente interno e externo por meio da natureza, sendo um estilo positivo por servir como distração de forma que o ser humano não precisa fazer esforço para captar seus estímulos sendo percebidas naturalmente. Essa visão do ambiente como parte do processo de cura é um dos pilares para as Práticas Integrativas e Complementares (PICS), que enfatizam a conexão entre o ser humano, o meio ambiente e a sociedade, onde o espaço construído é parte indissociável da promoção da saúde integral.

4.3.2 Escala humana como bem-estar: Design Inclusivo

Quando pensamos que a arquitetura deve ser intrínseca com o ser humano, é importante destacar que o indivíduo, visto como um ser complexo e abrangente, possui individualidades também em seu aspecto físico (escala limitada). Os distanciamentos das necessidades humanas se massificaram durante o início do novo estigma de produção desenvolvida após a Revolução Industrial onde sempre que um ser humano tem que se adaptar a um espaço que não é pensado para ele, distancia-o da sensação de familiarização e de pertencimento com o ambiente ou objeto (CAMBIAGHI, 2017).

Considerando que um ambiente se relaciona como um todo, a fórmula da composição de elementos para torná-los confortável, seguro, um elemento tátil e orientador qualitativo, segundo Vasconcelos (2014) é ser criativo com os diferentes tratamentos de superfícies, utilizando uma variedade de materiais e técnicas. Uma função e percepção de diferentes matérias podem proporcionar como estímulo positivo no ambiente, como citado, é a relação da arte (design) nos ambientes, principalmente nestes que proporcionam sensação de monotonia, como ambientes de esperas, assim é citado:

Estar em uma sala cuja função aparente é apenas esperar é uma prova do esvaziamento dos sentidos nos espaços férteis para intervenções em saúde. Enrijecer e emparelhar o nome – sala de espera – ao lugar é anunciar um ambiente isento de prazeres ou de novidades, é consolidar o tédio. (SATO; AYRES, 2015 apud SILVA, 2013)

Deste modo, a arte (design) surge como estratégia de acolhimento no espaço *“que escapa a reflexão da natureza humana, onde tão pouco é compreendida sua experiência por critérios científicos, assim conferindo novos modos de relação entre ser humano e a arte em si”* (SATO; AYRES, 2015 apud HERMANN, 2005). Com isso, a arquitetura e psicologia convergem na criação de ambientes voltados à escala humana e resiliência do indivíduo no espaço construído.

5. Conceitos

5.1 Fenomenologia

Ao abordar o campo teórico, a fenomenologia explica a arquitetura como uma forma de concretização do - habitar. Habitar, em um sentido existencial, significa ser capaz de se orientar e se identificar com um ambiente. Ao citar sobre, Norberg-Schulz (1980) que descreve sobre o termo - Genius Loci – enfatizando que *“a arquitetura significa visualizar o Genius Loci, e a tarefa do arquiteto é criar lugares significativos, pelos quais ajuda o homem a habitar”*.

O fenômeno é aquilo que se apresenta à consciência. O desafio de criar com materialidade uma "presença" que transcenda a técnica funcional, ainda que intencional.

A fenomenologia para Zumthor não é uma teoria abstrata, mas uma prática focada no encontro do ser humano com a realidade material do edifício, ele também defende que o propósito fundamental da arquitetura é tornar a existência humana significativa, transformando-a em um lugar com identidade própria. Na arquitetura, sob esta ótica, é "visualizar" esse espírito do lugar por meio do projeto.

Pallasma explica que é na multissensorialidade que criamos a fenomenologia, onde coloca o corpo humano no centro do mundo das experiências, criticando o que chamam de "hegemonia da visão". Para Zumthor se define como "atmosfera", na prática, é a totalidade de aspectos (som, temperatura, luz, materialidade) que compõem a qualidade de um ambiente e que emocionam o usuário. Apesar de definições por terminologias diferentes, todos os autores partem do mesmo, é na percepção dos sentidos fisiológicos do usuário que provocações de pertencimento acontecem dentro do ambiente construído (ou espaços de imersão).

5.2 Arquitetura do Bem – Estar (Healing Architecture)

Ao analisar como a arquitetura é capaz de influenciar uma emoção, é pela história evolutiva que se encontram respostas adaptativas em integração com a natureza, e para como a nossa saúde física e mental depende dessa conexão.

Segundo Stephen Kellert (2012), nunca seremos verdadeiramente saudáveis ou realizados se vivermos isolados dentro de um único ambiente (urbano). O ambiente é capaz de impactar três sistemas principais: cognitivo, psicológico e fisiológico, entendendo que o bem-estar é a necessidade funcional para uma espécie urbana.

Estudos como o de Roger Ulrich (1984) demonstram que pacientes em contato visual com a natureza recuperam-se mais rápido e usam menos medicações, provando que intervenções com design fundamentadas impactam na saúde, melhorando diretamente o processo dos sistemas específicos de um corpo humano.

As evidências científicas que sustentam a restauração cognitiva pela natureza baseiam-se, em grande parte, na Teoria da Restauração da Atenção (ART) (BROWNING, 2014).

5.3 Arquitetura Comportamental — o espaço como indutor de escolhas

Desenvolvido por Richard Thaler e Cass Sunstein (2008), o conceito de Nudge - ou efeito "estimulante" - parte da premissa de que toda arquitetura com intenção, influencia o comportamento, consciente ou inconscientemente — baseado que nenhuma escolha nos é apresentada de forma irrelevante. Aplicado ao ambiente construído, o Nudge pode sustentar decisões de projeto para que edifícios e espaços urbanos sejam projetados tendo as necessidades humanas no centro do processo - reconhecendo que as características espaciais influenciem profundamente o bem-estar e o comportamento - funcionando como indutores silenciosos para comportamentos mais saudáveis. Essa abordagem conecta-se diretamente em ambiências de PICs que acabam negligenciando essas variáveis, enquanto ambiências projetadas com intencionalidade comportamental favorecem a disposição para o cuidado e a adesão ao processo dos tratamentos.

Ao articular os conceitos, observa-se uma tensão entre a base qualitativa e filosófica e a base empírica e quantitativa. Por um lado, Roger Ulrich (1984) fundamenta-se na Arquitetura Baseada em Evidências, sustentando que elementos como o contato visual com a natureza geram respostas fisiológicas mensuráveis de forma empírica. Em contrapartida, Juhani Pallasmaa (2011) propõe uma abordagem fenomenológica, argumentando que o bem-estar não advém de estímulos isolados, mas de uma experiência multissensorial que reforça a identidade e a existência do sujeito pela configuração espacial.

Este trabalho articula essas perspectivas ao propor que a fenomenologia qualifica a percepção da atmosfera e o sentido de identidade, enquanto a Arquitetura do Bem-Estar e Comportamental fornece as evidências métricas de que atmosferas qualificadas reduzem indicadores fisiológicos desestimulantes. Ambas convergem na criação de uma ambiência terapêutica que reconhece o indivíduo não como uma patologia, mas como um ser integral de atenção na saúde e bem-estar.

6. Síntese

Partindo da compreensão de que o dinamismo cotidiano atua como um impulso para o sofrimento psíquico, ao introduzir os fundamentos teóricos, observa-se que a promoção do bem-estar se baseia em uma correlação multifacetada, fundamentada na premissa de que o design dos espaços desempenha um papel de estímulo na saúde física, mental e emocional do indivíduo. Tais intervenções são capazes de facilitar escolhas mais saudáveis ou

8. Referência Bibliográfica

BATISTA, M. K.; GRISCI, C. L. I.; GALLON, S.; FIGUEIREDO, M. D. **Slow Movement: trabalho e experimentação do tempo na vida líquido-moderna**. [S. l.: s. n.], 2013.

BRASIL. UNA-SUS. **OMS alerta que 10% da população global tem distúrbio de saúde mental**. 2015. Disponível em: <https://ippesbrasil.com.br/noticias/oms-alerta-que-10-da-populacao-global-tem-disturbio-de-saude-mental/>. Acesso em: 27 de abril de 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. **Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar**. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pnhah01.pdf>. Acesso em: 11 de maio de 2026.

BROWNING, W. D.; RYAN, C. O.; CLANCY, J. O. **14 Patterns of Biophilic Design: improving health & well-being in the built environment**. New York: Terrapin Bright Green, LLC, 2014. Disponível em: www.terrapinbrightgreen.com. Acesso em: 9 de maio de 2026.

CAMBIAGHI, Silvana. **Desenho Universal: métodos e técnicas para arquitetos e urbanistas**. São Paulo: SENAC, 2017. Disponível em: <https://books.google.com.br>. Acesso em: 5 de maio de 2026.

FUTURE HOLDING. **Arquitetura e Bem-estar: criando espaços que nutrem a alma**. 17 de maio de 2024. Disponível em: <https://pt-br.2future.co/post/architecture-and-well-being>. Acesso em: 9 de maio de 2026.

GUILHERMINO, Leila Araújo. **A fenomenologia da arquitetura na produção contemporânea: a aplicação da teoria na prática projetual**. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO, 3., 2014, São Paulo. Anais [...]. São Paulo: ANPARQ, 2014.

GUILHERMINO, Leila Araújo. **As atmosferas arquitetônicas de Peter Zumthor: uma arquitetura de dentro para fora**. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO, 4., 2016, Porto Alegre. Anais [...]. Porto Alegre: ANPARQ, 2016.

FIGUEIREDO A.M.N. **Práticas de enfermagem: fundamentos, conceitos, situações e exercícios**. São Paulo: Yendis, 2005.

JAMIESON, Timm. **Humanization of healthcare facilities in the new millennium: an architect's view**. [S. l.: s. n.], 2002. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/87380/206199.pdf>. Acesso em: 5 de maio de 2026.

KAPLAN, Rachel. **Preference and everyday nature: Method and application. Perspectives on environment and behavior: theory, research, and application**, New York: 138 Plenum, 1977.

KEHL, Maria Rita. **O tempo e o cão: a atualidade das depressões** / Maria Rita Kehl. - São Paulo : Boitempo. 2009.

KELLERT, Stephen R. **Birthright: people and nature in the modern world**. New Haven: Yale University Press, 2012.

MALARD, Maria Lúcia. **Os objetos do cotidiano e a ambiência**. In: ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRÚDO, 2., 1993, Florianópolis. Anais [...]. Florianópolis: ANTAC, 1993.

MARBERRY, Sara O. Roger Ulrich **discusses evidence-based design in healthcare**. Healthcare Design Magazine, 31 out. 2010. Entrevista concedida por Roger Ulrich. Disponível em: <https://healthcaredesignmagazine.com/trends/conversation-roger-ulrich/64/>. Acesso em: 9 de maio de 2026.

NORBERG-SCHULZ, Christian. **Genius Loci: towards a phenomenology of architecture**. New York: Rizzoli, 1980.

OMS. Organização Mundial da Saúde. **Classificação de TM e de comportamento da CID-10**. Porto Alegre: Artes Médicas; 1993. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1516-44461999000200014>>. Acesso em: 08 de maio de 2026.

OTANI, Márcia Aparecida Padovan; BARROS, Nelson Filice de. **A Medicina Integrativa e a construção de um novo modelo na saúde**. Ciência & Saúde Coletiva, São Paulo, v. n. 16, p.1801-1811, 07 ago. 2008.

PALLASMAA, Juhani. **Os olhos da pele: a arquitetura e os sentidos**. Tradução de Alexandre Salvaterra. Porto Alegre: Bookman, 2011.

REIS, Elisabete Rodrigues dos. **Lugar do sentido**. Revista Nufen: Phenom. Interd., Belém, v. 9, n. 2, p. 109-123, maio/ago. 2017.

TERRAPIN BRIGHT GREEN. **Biophilic Design: the theory, science, and practice of bringing buildings to life**, Chapters 22 & 23. [S. l.]: Terrapin Bright Green, [2026?]. Disponível em: <https://www.terrapinbrightgreen.com/publications/biophilic-design/>. Acesso em: 9 de maio de 2026.

THALER, Richard H.; SUNSTEIN, Cass R. **Nudge: improving decisions about health, wealth, and happiness**. New Haven: Yale University Press, 2008.

ULRICH, R. S. **View through a window may influence recovery from surgery**. Science, New Series, v. 224, n. 4647, p. 420-421, 27 abr. 1984.

ULRICH, R. S.; VOLLMER, T. C. **From experience to evidence**. In: VOLLMER, T.; LEPIK, A.; LUKSCH, L. (ed.). Building to heal: new architecture for hospitals. Berlin: ArchiTangle GmbH, 2023. p. 104-109.

VASCONSELOS, Renata Thaís Bomm. **Humanização de ambientes hospitalares: características arquitetônicas responsáveis pela integração interior/exterior**. Orientador: Vera Helena Moro Bins Ely. 2014. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014.

VILLELA, Mariana Silva; ELY, Vera Helena Moro Bins. **Humanização na ambiência de práticas integrativas e complementares: significado de bem-estar na perspectiva dos usuários**. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 27, p. 2011-2022, 2022